Processo n° **0052427-68.2022.8.17.2001**

AUTOR: MARIA LUCIA DE BUSTAMANTE SIMAS

RÉU: SUL AMERICA SEGUROS GERAIS S/A

SENTENÇA

MARIA LUCIA DE BUSTAMANTE SIMAS ajuizou ação em face de **SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A**, perseguindo: (i) a nulidade das cláusulas do contrato firmado entre as partes que limitam o tratamento da dermatite atópica grave da qual padece a autora; e (ii) a condenação da demandada: (ii.a) na obrigação de fazer consistente em autorizar o tratamento com o medicamento Dupixent 300 mg, e tudo o mais que for necessário para total restabelecimento da saúde da autora, sem qualquer limitação, restrição ou exclusão, conforme solicitação do médico assistente; (ii.b) a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Alega, em resumo, que:

(1) firmou com a demandada contrato de assistência à saúde (Código de identificação n° 545 88888 4502 6851 0013), e sempre honrou com as suas obrigações contratuais;

(2) desde os três anos de idade, é portadora de asma severa e perene e também de dermatite atópica grave (Eczema – CID L20), em 75% da superfície corporal, doença crônica e hereditária que causa inflamação da pele, levando ao aparecimento de lesões e coceira (xerose e prurido);

(3) em virtude da dermatite, foi acometida de blefarite – infecção das pálpebras que podem levar a perda da visão, em face do que já precisou de atendimentos emergenciais inúmeras vezes;

(4) passou a infância, a adolescência e parte da vida adulta sendo socorrida em emergências para injeções endovenosas de Teofilina (e hidrocortisona) para asma e, em virtude do uso quase contínuo da cortisona para tratamento da enfermidade, desenvolveu um processo de psicose (esquizofrenia) e faz uso constante de antipsicótico e antidepressivo para manter este transtorno sob controle;

(5) desde o surgimento do Fostair spray e Fostair DPI, faz uso diário de tais substâncias para o controle da asma com algum sucesso;

(6) porém, à medida em que a sua asma ficava razoavelmente sob controle, a sua dermatite atópica começou a piorar, até que, após os 52 (cinquenta e dois) anos e, sobretudo após a menopausa, a doença vem se espalhando pelo corpo: primeiro nos braços, torço e barriga, depois nas pernas e, ultimamente, fortemente no pescoço, nos braços, mãos e no rosto;

(7) o tratamento com cortisona tópica não se fez suficiente para controlar a enfermidade;

(8) durante os anos de 2019 e 2020, os entornos e contornos dos olhos foram fortemente afetados pela dermatite, gerando muita coceira e, como consequência, chegou a causar lesão nas córneas de ambos os olhos em tempos diferentes;

(9) atualmente a dermatite atópica está espalhada por todo o corpo e causa forte coceira, e como consequência, causa lesões na pele e sangramento (às vezes constrangedor em situações sociais), suja constantemente de sangue os lençóis, fronhas e roupas e, além de causar dor na pele sob o sol, não é socialmente confortável nem agradável ir à praia, ou expor o corpo, nestas condições;

(10) conquanto, em condições normais, a sua Imunoglobolina não devesse ser maior que 100 kU/L, hoje a Imunoglobolina da autora é de 14.630 kU/L (nível 6);

(11) para o tratamento da doença, a autora necessita utilizar medicamento com efeitos colaterais significativos, quais sejam osteoporose, obesidade, diabetes, hipertensão e catarata;

(12) tais medicamentos, além de causarem diversos efeitos colaterais, apresentam controle mínimo da doença;

(13) por tais razões, o médico assistente que a acompanha, Dr. José Ângelo Rizzo – CRM/PE 5053, prescreveu o medicamento Dupixent 300 mg, que não apresenta efeitos colaterais e representa chance de grande controle da doença;

(14) o medicamento deve ser utilizado de forma contínua na dosagem de 300 mg, 02 (duas) doses por injeções subcutâneas na primeira tomada e depois uma dose pela mesma via a cada 15 (quinze) dias;

(15) conforme atesta o médico assistente, a doença compromete a qualidade de vida da Autora, diminuindo sua rentabilidade no trabalho e sua autoestima, impossibilitando-a de frequentar diversos lugares e de ter um convívio social saudável;

(16) ocorre que, ao efetuar o requerimento, a Ré não autorizou o medicamento, sob o fundamento de que "de acordo com a cláusula de cobertura do seu contrato, somente há cobertura para os procedimentos listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS".

Pediu que, em sede de tutela provisória de urgência, este juízo determinasse que a demandada autorizasse o tratamento com o medicamento Dupixent 300 mg, de forma contínua, na dosagem de 300 mg, 02 (duas) doses por injeções subcutâneas na primeira tomada e depois uma dose pela mesma via a cada 15 (quinze) dias, e tudo o mais que for necessário para total restabelecimento da saúde da autora, sem qualquer limitação, restrição ou exclusão, conforme solicitação do médico assistente, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Juntou documentos.

As custas e despesas processuais, nos valores de R$276,26 (duzentos e setenta e seis reais e vinte e seis centavos) e 269,76 (duzentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), foram adiantas pela parte autora em 16.5.2022 (ID 105485296) e 12.9.2022 (ID 114706288).

Instada, a parte ré manifestou-se acerca do pedido de tutela provisória de urgência (ID 106347897) e apresentou contestação (ID 107522147).

Alega, em suma, que:

a) está adstrita à cobertura dos procedimentos legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos, dentre os quais não se encontra o custeio do tratamento pretendido pela demandante;

b) o fornecimento do medicamento Dupixent somente é assegurado ao beneficiário do contrato de assistência à saúde nos casos especificados na DUT n. 65.9 da ANS;

c) o caso da autora não se enquadra nos critérios estabelecidos pela ANS para cobertura da terapia imunobiológica pretendida, razão pela qual foi objeto de negativa de cobertura;

d) não praticou nenhum ato capaz de ensejar indenização por danos morais.

Juntou documentos.

Por meio da decisão de ID 111552536, pedido de tutela provisória de urgência restou deferido.

Na sequência, a operadora ré informou o cumprimento da decisão antecipatória (ID 112203923) e noticiou a interposição de agravo de instrumento (ID 113542948).

Instada, a demandante apresentou réplica (ID 116026148).

As partes não demonstraram interesse na produção de provas complementares e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 117268115 e 117608028).

É o que importa relatar. Decido.

O feito comporta julgamento antecipado, nos moldes do disposto no art.355, I, do CPC/2015, porquanto desnecessária a produção de outras provas. Destaque-se ainda que, conquanto intimadas para especificar as provas cuja produção tivessem interesse, as partes nada requereram.

Do laudo médico apresentado pela promovente (ID 105400085), infere-se que, para o tratamento das doenças de que foi acometida (asma e dermatite atópica grave), o médico assistente prescreve a administração do fármaco Dupixent (300mg), por via subcutânea (2 doses na primeira tomada e depois uma dose a cada 15 dias).

Assevera o médico que: a) a paciente encontra-se com 75% da superfície corporal com comprometimento, com prurido intenso, ardor e dor, com prejuízo do sono, da produtividade no trabalho, bem como da autoestima; b) já se submeteu a diversos tratamento emergenciais devido a lesões de córnea, com formação de cicatriz ocular; c)usa medicamentos que ensejam efeitos colaterais consideráveis (psicose, osteoporose, obesidade, diabetes, hipertensão e catarata); d) "o medicamento proposto (Dupixent) não tem esses efeitos colaterais e representa uma chance bastante grande de controle da doença e dos sintomas"; e)os tratamentos convencionais não provocaram resposta satisfatória.

Extrai-se dos autos que a ré negou a cobertura, sob o argumento de que o tratamento prescrito não se enquadra na Diretriz de Utilização nº65 estabelecida pela ANS (ID 105400093).

O contrato firmado entre as partes encerra relação de consumo, desafiando a aplicação da legislação consumerista, nos exatos termos do enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de planos de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão).

Além disso, ao caso também deve ser aplicada a Lei 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Da leitura art. 10 da Lei 9.656/98, extrai-se que o plano-referência, que deverá ser obrigatoriamente oferecido por toda e qualquer operadora de contrato de assistência à saúde, deve necessariamente assegurar cobertura a todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, ressalvadas as exclusões enumeradas nos incisos I a X.

No presente caso, segundo laudo médico juntado aos autos, a parte autora é portadora de doenças que constam da lista da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, a saber asma e dermatite atópica grave, e que, portanto, possuem cobertura pelo contrato de assistência à saúde do qual é beneficiária.

Tratando-se, portanto, de patologias listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, cuido ser obrigatória a cobertura do seu tratamento pelas operadoras de planos de saúde.

Além disso, consta do art.12, I, alínea b, da Lei 9.656/1998, a obrigatoriedade de cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamento e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo médico assistente.

A despeito da alegação da ré de não previsão do tratamento pretendido pela autora em Diretriz de Utilização nº 65 da ANS, tenho que a operadora demandada não pode se recusar a custeá-lo única e exclusivamente sob a alegação de ausência de previsão no rol de procedimentos da ANS, quando imprescindível ao restabelecimento da beneficiária, segundo o médico assistente, como ocorre *in casu*, **considerando a declaração médica de insucesso dos tratamentos anteriormente realizados, dos inúmeros efeitos colaterais causados pelas medicações usuais e de progressão da doença.**

Retenha-se que a medicação Dupilumabe passou a fazer parte da DUT 65 da ANS a partir de 01.04.2022, com indicação de seu uso para asma eosinofílica grave, desde que preenchidos alguns critérios.

Destaque-se também que, ainda que se conclua, à vista do recente julgamento do STJ, no sentido de que o rol de procedimento e eventos em saúde emanado da ANS é taxativo, impõe-se perceber que aquele julgado ressalvou a cobertura de tratamento efetivamente imprescindível para a saúde do beneficiário, ainda que não previsto no rol de procedimentos.

Sobreleva mencionar ainda a **existência de inúmeros pareceres favoráveis ao uso do fármaco Dupilumabe no tratamento de dermatite atópica grave, conforme consulta à base pública do e-NatJus[i] (file:///D:/Amanda%202022/Novembro/senten%C3%A7a%20-%20medicamento%20-%20dut%20ans%20-%20DUPILUMABE.docx#_edn1), em que se constata a eficácia e segurança do medicamento para realização do tratamento pretendido neste feito.**

Ademais, ao longo da tramitação do presente feito, fora publicada a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que altera a Lei nº 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar.

Confira-se:

> Art.10. (...) § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente **que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo**, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
>
> I – **exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico**; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)
>
> II – existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (grifei)

Nesse contexto, ao tempo em que **tenho por injusta a recusa da ré em custear o tratamento medicamentoso prescrito pelo médico assistente da autora, confirmo os efeitos da decisão antecipatória de tutela** deferida nos autos.

A pretensão de reparação civil por danos morais também merece acolhida.

Malgrado, em regra de princípio, o mero inadimplemento contratual seja insuficiente à configuração de danos extrapatrimoniais, a jurisprudência vem reconhecendo que a indevida recusa a cobertura de contrato de assistência à saúde pode sim ensejar a configuração de dano moral indenizável (STJ: AREsp 946150/SP; AREsp 919439/RJ; AREsp 708894/DF; AgInt no AREsp 1022746/RN; AgRg no AREsp 666568/RJ).

É que, se de um lado é certo que, no mais das vezes, o não cumprimento de obrigação contratual impõe prejuízos de ordem unicamente material, de outro, importa ver que, em determinadas circunstâncias, o descumprimento do contrato pode exacerbar a seara patrimonial, dando causa a uma violação dos direitos da personalidade, ao comprometimento da honra, da dignidade ou da intimidade da pessoa humana, ou mesmo deflagrando ou agravando séria e compreensível situação de angústia, insegurança, aflição ou dor psíquica e/ou física de quem já se acha com a saúde debilitada. Nessas situações, do descumprimento do contrato decorrerá não só danos materiais, mas também morais, e, dado que a Constituição da República adotou o princípio da reparação integral (art. 5º, V e X), além de responder pelas perdas e danos materiais (art. 389 do CC), o responsável pelo inadimplemento deverá indenizar também os danos extrapatrimoniais.

Certamente, a recusa na autorização do tratamento médico solicitado pela autora e prescrito pelo seu médico assistente, em razão do diagnóstico de asma e dermatite atópica grave, foi suficiente para agravar a angústia, a

insegurança, a aflição e a dor psíquica da qual inexoravelmente já se achava acometida a paciente.

Em verdade, não há como deixar de reconhecer que a promovente, já extremamente desgastada física e emocionalmente, viu-se inesperadamente desamparada justamente por aquele que foi contratado e remunerado para ampará-la nessa circunstância.

Ora, quem se vincula a contrato de assistência à saúde o faz em busca de segurança e confiança futura para os seus bens mais preciosos: a saúde e a vida. Assim, o descumprimento de contrato dessa natureza, ao frustrar tais expectativas, impingindo ao paciente a sensação de abandono, à toda evidência é capaz de causar-lhe profunda dor psíquica e sofrimento indenizável a título de dano moral.

À vista de tais considerações, tenho como configurados o dano moral e o dever de indenizar.

Fixo o valor da indenização.

A indenização em face do dano moral tem caráter reparatório e punitivo-pedagógico. De um lado, objetiva reparar, ainda que de forma paliativa, a angústia experimentada pelo lesado. De outro, visa motivar o ofensor a adotar novas práticas, cercando-se de novos cuidados, a fim de não mais incidir em condutas ilícitas da mesma natureza, vale dizer, tenciona impedir a repetição de fatos idênticos ou assemelhados.

De realçar ainda a orientação do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na fixação do quantum indenizatório de dano moral "[...] recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores e, ainda, ao porte econômico dos réus, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso" (REsps. nºs. 214.381-MG; 145.358-MG e 135.202-SP).

No caso dos autos, tenho que a demandada agiu com culpa grave, pois quando da desídia em autorizar o tratamento da autora, **tinha ciência das complicações em seu quadro de saúde, da ineficácia dos demais tratamentos e do elevado comprometimento em sua qualidade de vida.** Inarredável a conclusão de que o descumprimento contratual foi voluntário e consciente, agindo a ré com culpa grave.

Por outro lado, a demandada é empresa de significativo porte financeiro. Indenização modesta em termos pecuniários certamente não a estimulará a revisar conceitos e comportamentos com o objetivo de não mais praticar a conduta ilícita. Ademais, indenizações módicas têm permitido que os fornecedores em geral lucrem com a ofensa moral, preferindo, aqui e ali,

arcarem com indenizações a aparelharem-se adequadamente segundo as exigências do mercado consumidor e as interpretações assentadas pelo Poder Judiciário.

Assim, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando sobretudo as peculiaridades do caso, já bem delineadas, para garantir à parte autora a justa reparação pelos danos sofridos, sem que incorra em enriquecimento ilícito, e ainda atenta ao caráter punitivo-pedagógico da reprimenda, fixo a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

À vista do exposto, extinguindo o processo com resolução de mérito, julgo procedentes os pedidos (art. 487, I do CPC/2015) e, confirmando os efeitos da decisão antecipatória, condeno a demandada a:

1. custear o tratamento médico da autora com a medicação Dupilumabe, conforme prescrição médica;

2. pagar à demandante, a título de indenização por danos morais, R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de correção monetária (índices da tabela do Encoge), a partir do presente arbitramento (súmula 362 do STJ), e de juros legais de mora (1% - um por cento ao mês - art. 406 do CC c/c art. 161, §1°, do CTN), a partir da data da citação (art. 405 do CC);

3. ressarcir à parte autora os valores recolhidos a título de adiantamento de custas e despesas processuais (R$276,26 e 269,76), atualizados pela Tabela Encoge desde a data de cada desembolso (16.5.2022 - ID 105485296 e 12.9.2022 - ID 114706288).

4. pagar ao(s) advogado(s) constituído(s) pela parte autora honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do proveito econômico obtido pela demandante, que corresponde à soma do valor da indenização por danos morais com o valor dos custos do tratamento médico cuja cobertura foi imputada à ré, tudo com fulcro no art. 85, §2°, do CPC/2015, na Súmula 27 do TJPE e no atual entendimento do STJ.[ii] (file:///D:/Amanda%202022/Novembro/senten%C3%A7a%20-%20medicamento%20-%20dut%20ans%20-%20DUPILUMABE.docx#_edn2)

Em face da pendência de julgamento do agravo de instrumento n°0015747-39.2022.8.17.9000, expeça-se ofício ao Gabinete do Exmo. Des. Relator, informando acerca do julgamento do presente feito.

Opostos embargos de declaração com efeito modificativo, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. (art. 1.023, § 2°, do CPC/2015), e decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões (art. 1010, §1º, do CPC/2015). Havendo alegação – em sede de contrarrazões - de questões resolvidas na fase de conhecimento as quais não comportaram agravo de instrumento, intime-se a parte adversa (recorrente) para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas (art. 1.009, §§ 1º e 2º, do CPC/2015). Havendo interposição de apelação adesiva, intime-se a parte apelante para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 1.010, §2º, do CPC/2015). Em seguida, com ou sem resposta, sigam os autos ao e. Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, com os cumprimentos deste Juízo (art. 1010, §3º, do CPC/2015).

Após o trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo, independentemente de nova determinação. Intimem-se.

Recife/PE, data da assinatura digital.
Mariana Vargas Cunha de Oliveira Lima
Juíza de Direito

---

[i] (file:///D:/Amanda%202022/Novembro/senten%C3%A7a%20-%20medicamento%20-%20dut%20ans%20-%20DUPILUMABE.docx#_ednref1) https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php (https://www.cnj.jus.br/e-natjus/pesquisaPublica.php)

[ii] (file:///D:/Amanda%202022/Novembro/senten%C3%A7a%20-%20medicamento%20-%20dut%20ans%20-%20DUPILUMABE.docx#_ednref2) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO MÉDICO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. 1. A obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida, utilizando-se como parâmetro o valor da cobertura indevidamente negada. Precedentes.

2. Nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer.

3. Embargos de divergência providos.

(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 198.124 - RS (2012/0136891-6)

Assinado eletronicamente por: MARIANA VARGAS CUNHA DE OLIVEIRA LIMA
10/11/2022 21:18:29
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 119500538

22111021182969400000116807752

IMPRIMIR GERAR PDF